

Memoria Académica

1. Ficha Técnica

Título del Programa

State of the Art in Renal Cell Carcinoma: Self-Assessment Program.

Entidad Organizadora / Proveedor Educativo

Hygeia Learning Hub.

Fuente Científica Exclusiva

Contenidos seleccionados y adaptados de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), incluyendo Journal of Clinical Oncology (JCO), JCO Precision Oncology, y ponencias oficiales de los congresos anuales de ASCO GU.

Modalidad de Impartición

Formación 100% Online (E-learning interactivo) + Webinar de Apertura en Directo.

Fechas Previstas de Edición

De Octubre 2026 a Mayo 2027 (Plataforma abierta durante 8 meses).

Acreditación Solicitada

Créditos de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud (SNS) para las profesiones sanitarias.

Avales Científicos Solicitados

- Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
- Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG).

Patrocinio / Soporte Educativo (Unrestricted Educational Grant)

Programa financiado a través de una beca formativa no condicionada (Sponsor Objetivo: MSD). Las entidades patrocinadoras no intervendrán en el diseño pedagógico, ni en la selección de los autores, ni en el contenido científico independiente del programa.

2. Presentación del curso

El programa formativo "State of the Art in Renal Cell Carcinoma: Innovación, Secuenciación y Humanismo" nace como una iniciativa de excelencia médica impulsada por Hygeia Learning Hub para dar respuesta a la vertiginosa evolución del tratamiento de los tumores genitourinarios. Se trata de un curso de actualización avanzada, estructurado en formato e-learning interactivo, diseñado para acompañar al especialista en uno de los desafíos clínicos más complejos de la actualidad: la óptima secuenciación terapéutica y el manejo del paciente refractario a los dobletes de inmunoterapia y antiangiogénicos.

A través de una rigurosa selección de literatura científica, el programa articula un currículum de tres módulos estratégicos. Este recorrido académico abarca desde la estratificación del riesgo y la biología de la vía de la hipoxia (eje VHL/HIF-2 α), pasando por la evidencia clínica de las nuevas dianas y regímenes adyuvantes, hasta culminar en un enfoque humanista centrado en la preservación de la función orgánica, el manejo de toxicidades crónicas y la calidad de vida.

El curso se inaugurará con un Seminario Web (Kick-off) de alto nivel liderado por un referente nacional de SOGUG, y se desarrollará bajo una metodología pedagógica de alto impacto que incluye casos clínicos narrativos, análisis de controversias (Critical Debate) y herramientas de aplicabilidad inmediata en la consulta real (Practice Insights). La exigencia de una autoevaluación constante (Self-Assessment) garantiza que el alumno desarrolle las competencias críticas necesarias para liderar la nueva era de la oncología urológica en el Sistema Nacional de Salud.

3. Justificación de la actividad

El manejo clínico del Carcinoma de Células Renales (CCR) se encuentra en un punto de inflexión histórico. Si bien la combinación de inhibidores de puntos de control inmunitario (PD-1/L1) e inhibidores de la tirosina cinasa (TKI) ha transformado radicalmente el pronóstico en la primera línea de la enfermedad avanzada, la inmensa mayoría de los pacientes terminan progresando. El oncólogo se enfrenta entonces a un "paciente multitratado" donde el arsenal terapéutico tradicional (inhibidores de mTOR o TKI secuenciales) ofrece respuestas limitadas y toxicidades acumuladas limitantes.

Paralelamente, los pacientes con el síndrome hereditario de Von Hippel-Lindau (VHL) se han visto históricamente abocados a múltiples cirugías repetitivas (nefrectomías, cirugías del SNC) que comprometen severamente su funcionalidad, sin disponer de opciones sistémicas efectivas.

En este contexto, la inhibición específica del factor inducible por hipoxia 2 alfa (HIF-2 α) — fruto de las investigaciones reconocidas con el Premio Nobel de Medicina en 2019— emerge como un paradigma revolucionario. Moléculas como belzutifán plantean un escenario clínico inédito, ofreciendo un nuevo mecanismo de acción para el paciente politratado (LITESPARK-005) y la primera terapia sistémica aprobada para evitar cirugías mutilantes en pacientes con VHL (LITESPARK-004).

La irrupción de esta innovación exige que el especialista actualice sus competencias en tres dimensiones críticas, las cuales justifican el desarrollo integral de este programa:

Dimensión Molecular y Diagnóstica: Es imperativo comprender la base fisiopatológica del CCR de células claras, integrar factores pronósticos (clasificación IMDC) y sospechar tempranamente la presencia de síndromes hereditarios (mutación VHL).

Dimensión Clínica y Secuenciación: Resulta necesario dominar la abrumadora evidencia de los recientes congresos sobre inmunoterapia en estadios precoces y avanzados, estableciendo algoritmos seguros para la toma de decisiones en la tercera línea y posteriores (3L+).

Dimensión Humanista e Integral: El manejo de nuevas toxicidades, como la hipoxia inducida o la anemia crónica, obliga a repensar el modelo de cuidado. El especialista necesita incorporar herramientas de Toma de Decisiones Compartida (SDM), preservar la dignidad del paciente al final de la vida y coordinar un soporte multidisciplinar que evite la "toxicidad financiera y vital" de la enfermedad.

4. Objetivos de la actividad

4.1 Objetivo General

Capacitar al especialista en el manejo clínico integral del Carcinoma de Células Renales (CCR) bajo los nuevos paradigmas de secuenciación terapéutica y medicina de precisión, integrando el conocimiento del eje VHL/HIF con un enfoque humanista centrado en la optimización de la calidad de vida y la experiencia del paciente.

4.2 Objetivos Específicos

De conocimiento molecular y diagnóstico:

- Comprender la relevancia biológica de la vía de detección de oxígeno y la hiperactivación de HIF-2 α en el CCR.
- Aplicar correctamente la estratificación de riesgo IMDC e identificar los criterios para el diagnóstico clínico y genético de la enfermedad de Von Hippel-Lindau.

De manejo clínico y terapéutico:

- Analizar la evidencia científica de supervivencia y respuesta de las combinaciones IO-TKI y de la nueva clase de inhibidores de HIF-2 α en líneas avanzadas.
- Aplicar algoritmos de decisión clínica para la secuencia terapéutica óptima en pacientes con CCR refractario a la inmunoterapia y terapias anti-VEGF.
- Dominar los protocolos de prevención y manejo proactivo de toxicidades especializadas (anemia, hipoxia).

De habilidades humanísticas y comunicación (Soft Skills):

- Incorporar el modelo de Toma de Decisiones Compartida (SDM) al proponer cambios de línea de tratamiento o retrasar cirugías (en VHL).
- Evaluar el impacto de la fatiga terapéutica mediante Patient Reported Outcomes (PROs).
- Implementar estrategias de resiliencia profesional ("cuidar al que cuida") frente al desgaste en la atención de pacientes complejos.

5. Estructura y Contenidos Académicos

El programa se estructura en tres módulos diseñados bajo un modelo de aprendizaje progresivo. Cada módulo garantiza la adquisición integral de competencias mediante 8 apartados pedagógicos.

Módulo 1: Paisaje Molecular y Perfilado Genómico: Hacia una Selección Terapéutica más Precisa en el Carcinoma de Células Renales.

Objetivo: Comprender las bases moleculares del CCR, integrar factores pronósticos en la clínica y diferenciar el manejo según la biología tumoral.

- Executive Brief: "Más allá de la histología: El impacto de la mutación VHL, la vía de la hipoxia (HIF-2 α) y la clasificación IMDC".
- Scientific Core: Artículos sobre el mecanismo de detección de oxígeno y la justificación genómica del VHL.
- Critical Debate: "¿Es suficiente la clasificación IMDC en la era de la medicina de precisión?".
- Further readings: Guías ESMO/EAU sobre estratificación de riesgo.

- Practice Insights: Algoritmo práctico para la estratificación del paciente en la consulta.
- Clinical Cases: Caso diagnóstico: Paciente joven con CCR incidental y hemangioblastomas (VHL).
- Self-Assessment: Cuestionario interactivo con feedback.
- Multimedia: Animación 3D del mecanismo VHL/HIF-2 α .

Módulo 2: Reconfigurando el Algoritmo de Tratamiento: Inmunoterapia de Vanguardia y Estrategias Combinadas en el Escenario Avanzado.

Objetivo: Analizar la evidencia clínica reciente para establecer la mejor secuencia terapéutica (1L a 3L+).

- Executive Brief: "El rompecabezas de la secuenciación: Optimizando el arsenal terapéutico cuando la enfermedad progresa".
- Scientific Core: Estudios pivotaes en adyuvancia (ej. KEYNOTE-564) y análisis profundo de ensayos en líneas avanzadas y VHL (LITESPARK-005 y 004).
- Critical Debate: "El desafío de la tercera línea (3L+): TKI, inhibidores de mTOR o inhibidores de HIF-2 α ".
- Further readings: Bibliografía de ASCO GU sobre respuestas sostenidas en CCR politratado.
- Practice Insights: Tablas de decisión secuencial y criterios de elegibilidad.
- Clinical Cases: Resolución del switch terapéutico en un paciente con progresión a pembrolizumab+lenvatinib.
- Self-Assessment: Cuestionario interactivo con feedback.
- Multimedia: Línea de tiempo interactiva (Patient Journey) de secuenciación.

Módulo 3: El Paciente en el Centro de la Innovación: Un Enfoque Humanista para la Excelencia en el Cuidado y la Calidad de Vida.

Objetivo: Posicionar la preservación de la calidad de vida y el manejo humanista de toxicidades como pilares del éxito terapéutico.

- Executive Brief: "Curar, Prolongar y Acompañar: Gestión de toxicidades crónicas y el reto del Burnout".
- Scientific Core: Artículos sobre PROs, Cuidados Paliativos precoces y manejo de la anemia/hipoxia.
- Critical Debate: "El paradigma de evitar la cirugía en síndromes hereditarios y el valor de las terapias orales".
- Further readings: Recursos de Medicina Narrativa aplicados a la urología oncológica.
- Practice Insights: Check-list para el manejo de toxicidades limitantes en consulta.

- Clinical Cases: Role-play sobre la comunicación de toxicidad y toma de decisiones compartida.
- Self-Assessment: Cuestionario interactivo con feedback.
- Multimedia: Entrevista médico-paciente sobre el impacto de vivir con CCR avanzado.

6. Dirección Académica e Institucional

Editor en Jefe del Programa y editor del modulo 3

Dr. Pere Gascón.

Catedrático, director de la cátedra CELLEX de Oncología y del Conocimiento Multidisciplinar. Ex jefe del Servicio de Oncología Médica y Coordinador Científico del Instituto Clínico de Enfermedades Hemato-Oncológicas del Hospital Clínic de Barcelona.

Editor del Módulo 1. Paisaje Molecular y Perfilado Genómico:

Dr. Juan Ruíz Bañobre.

Especialista en clasificación molecular de tumores genitourinarios. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Editora del Módulo 2. Reconfigurando el Algoritmo de Tratamiento:

Dra. Cristina Suárez Rodríguez.

Especialista en Oncología Médica, investigadora del Programa de Tumores Genitourinarios del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO). Miembro destacado de SOGUG y experta en ensayos clínicos en cáncer renal.

7. Público Objetivo

El programa está dirigido a los profesionales implicados en el abordaje multidisciplinar del cáncer renal:

- Oncólogos Médicos: Responsables directos de la prescripción. Requieren una actualización exhaustiva en secuenciación tras IO-TKI y el manejo de los nuevos inhibidores de HIF-2 α .
- Urólogos: Claves en el abordaje quirúrgico inicial y en el seguimiento de la enfermedad localizada. Su conocimiento de la biología molecular es fundamental para evitar nefrectomías innecesarias en pacientes con VHL.
- Anatomopatólogos y Genetistas: Fundamentales para el consejo genético, la confirmación de subtipos histológicos y la detección de mutaciones germinales (VHL).

- Farmacia Hospitalaria: Responsables de gestionar la dispensación de nuevos agentes orales (como belzutifán) y monitorizar sus interacciones y adherencia.
- Médicos Internos Residentes (MIR): Esencial para garantizar que la nueva generación integre la fisiopatología, la innovación terapéutica y el humanismo desde el inicio de su carrera.

8. Metodología y Sistema de Evaluación

8.1. Metodología Docente (UX y Navegación)

El curso se aloja en un entorno virtual de aprendizaje (LMS) avanzado y responsive. La metodología es asíncrona, permitiendo al especialista conciliar la formación con su carga asistencial.

El flujo de navegación es secuencial: el alumno no podrá acceder al examen final sin haber visualizado previamente el 100% de los contenidos y superado las evaluaciones formativas intermedias.

8.2. Sistema de Evaluación Integral

El programa implementa un doble sistema de evaluación para certificar la adquisición de competencias, cumpliendo con los estándares de la CFC:

Evaluación Formativa Continua (Self-Assessments):

Al finalizar cada módulo, el alumno completará un cuestionario de 10 preguntas tipo test. Cada respuesta ofrece un feedback razonado de forma inmediata referenciando la literatura del Scientific Core.

Evaluación Sumativa Final:

Examen Final Online de 30 preguntas de opción múltiple (extraídas aleatoriamente de la base de datos). Criterios de superación: 80% de aciertos (máximo 2 intentos).

Encuesta de Calidad y Satisfacción:

Obligatoria tras el examen para valorar la calidad científica y pedagógica.

Acreditación y Diplomas:

Descarga automática y segura del Diploma Acreditativo con los logotipos de los avales (SEOM, SOGUG) y los Créditos CFC del SNS.

Anexo.

Estructura curso State of the Art

Acreditación y avales

- Programa dotado de créditos de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud (SNS)
- Contenidos de las sociedades médicas internacionales correspondientes
- Avalados por las sociedades médicas nacionales correspondientes.

Estructura del curso

- El programa contendrá 3 o más módulos de especialidades relevantes seleccionadas.
- **Presentación del programa: (Opcional).** Seminario web de 45 minutos con: una presentación de 30 minutos del programa por parte del editor jefe o un ponente invitado, y 15 minutos de preguntas y respuestas. -Experto internacional-.
- **Cada módulo contiene:**
 - *Executive Brief:* Introducción al módulo en texto + podcast.
 - *Scientific Core:* artículos completos que incluyen puntos clave.
 - *Critical Debate:* artículos con cuestiones clínicas y controversias actuales.
 - *Further readings:* Resúmenes con enlaces a PubMed o a las revistas correspondientes, si son de acceso libre.
 - *Practice Inside:* cómo aplicar en la práctica la información presentada. Un resumen práctico en forma de «mensajes para llevar a casa».
 - *Clinical Cases:* una selección de casos con preguntas y respuestas para practicar los conceptos teóricos
 - *Self-Assessment:* preguntas y respuestas interactivas.
 - *Multimedia:* Material audiovisual complementario.
- **Certificado de participación con los créditos otorgados.**